

Ректоуретральный свищ (у мужчин)

Информация для пациента · Патологическое соединение между прямой кишкой и мочеиспускательным каналом

WARWIKI

Ректоуретральный свищ — это патологический ход (небольшой тоннель) между **прямой кишкой** и **уретрой** (мочеиспускательным каналом). Через него моча может попадать в прямую кишку, а газы и кал — в мочу, вызывая повторные инфекции. Это тяжёлое состояние, однако оно поддаётся хирургическому лечению — как правило, поэтапному.

Об этом состоянии

Типичные симптомы: **газы или кал в моче** (пузырьки при мочеиспускании, мутная или зловонная моча), **выделение мочи через прямую кишку**, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей и дискомфорт в области таза. Это проблема «труб», требующая «сантехнического» решения — она никак не связана с вашими действиями.

Причины

Большинство ректоуретральных свищей возникает как **осложнение лечения рака предстательной железы** — операции (простатэктомии), **лучевой терапии** или абляции (криотерапии, HIFU) — либо после операции на прямой кишке. Реже причиной становятся травма, инфекция или воспалительные заболевания кишечника. Свищи, возникшие после **лучевой терапии**, заживают труднее.

ТЕРМИНЫ

Свищ (фистула)

Патологический ход, соединяющий два органа.

Ректоуретральный

Между прямой кишкой и уретрой.

Пневматурия

Газ/пузырьки в моче.

Фекалурия

Примесь кала в моче.

Деривация

Временное отведение мочи и/или кала для заживления.

Колостома

Временное отверстие для кала, которое впоследствии закрывают.

Лоскут *m. gracilis*

Мышечный лоскут из бедра, часто используемый для укрепления зоны пластики.

ЗАЧЕМ МНЕ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ВРЕМЕННАЯ СТОМА ИЛИ КАТЕТЕР? Отведение мочи (катетер или трубка) и иногда кала (временная колостома) снимает нагрузку с зоны свища, контролирует инфекцию и даёт тканям успокоиться — что повышает шансы на успешное заживление. Отведения обычно **временны** и устраняются после заживления.

Как это диагностируют

- Осмотр мочевого пузыря/уретры (**цистоскопия**) и прямой кишки
- **Контрастные тесты** и визуализация для определения размера и расположения свища
- Анализ истории болезни (лечение простаты, лучевая терапия) и состояния тканей

Как это лечат

- 1 **Стабилизация и деривация** — катетер (и при необходимости временная колостома) для контроля симптомов и восстановления тканей.
- 2 **Хирургическая пластика** — как правило, трансперинеальным доступом (между мошонкой и задним проходом) с послойным закрытием дефекта.
- 3 **Тканевой лоскут** — здоровая мышца (чаще всего лоскут **m. gracilis** из бедра) укладывается между линиями швов, особенно после лучевой терапии.
- 4 **Закрытие стом** — временные стомы устраняются позднее, после подтверждения заживления.

Важно знать

- Сроки имеют значение — хирурги обычно ждут стихания воспаления перед пластикой.
- Небольшие свищи без лучевого поражения иногда закрываются только при дренировании катетером.
- Полноценное питание и отказ от курения способствуют заживлению.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Повышение температуры, озноб или резкое ухудшение самочувствия** (возможная тяжёлая инфекция)
- Сильная боль в области таза или прямой кишки
- **Невозможность помочиться** или обильное кровотечение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Ректоуретральный свищ соединяет прямую кишку и уретру — вызывая газы/кал в моче и инфекции — чаще всего после лечения рака предстательной железы.
2. Лечение поэтапное: сначала деривация и стабилизация, затем пластика (нередко с тканевым лоскутом, особенно после облучения), затем закрытие временных стом.
3. Свищ поддаётся лечению. При повышении температуры, сильной боли или невозможности помочиться немедленно обратитесь за медицинской помощью.